



Taller 2

Más allá del prisma

Programa de Formación para Profesionales de la Salud Mental — Taller 2

Presentación del caso: El laberinto del pánico y la palabra sitiada

El cuadro clínico

Valeria, de treinta y ocho años, consultó por un cuadro de crisis de angustia recurrentes, agorafobia invalidante y un insomnio severo de más de un año de evolución.

Profesionales de la salud mental la habían derivado a un prestigioso servicio de psiquiatría donde se le diagnosticó **"trastorno de pánico con agorafobia y episodio depresivo secundario"**. Le habían prescrito una combinación de altas dosis de clonazepam y un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS).

La paradoja del tratamiento

Sin embargo, el cuadro no sólo no cedía, sino que se había vuelto abyecto. Valeria deambulaba por su casa en un estado de sopor farmacológico diurno —con embotamiento cognitivo y sensación de irrealidad (desrealización)—, pero por las noches, al bajar la dosis o intentar descansar, sufría crisis de pánico tan violentas que sentía que se ahogaba o perdía la razón.

Había iniciado paralelamente un psicoanálisis clásico, pero las sesiones eran un martirio: el colega intentaba interpretar las asociaciones libres o el "temor a la castración" mientras Valeria apenas podía mantener los ojos abiertos por la sedación o temblaba aferrada a los posabrazos del sillón, atrapada en un estado absoluto de **desregulación autonómica**.

Análisis desde la Clínica de la Convergencia

Desde el reduccionismo biologicista, el caso se leía como un fracaso farmacológico por "resistencia a las moléculas". Desde el hermetismo psicoanalítico ortodoxo, se culpabilizaba al fármaco de "tapar la angustia". La **lectura convergente** detectó de inmediato el error estructural:

El colapso de la ventana de tolerancia

Valeria oscilaba pendularmente entre la **hipoactivación tóxica** (inducida por el exceso de benzodiacepinas mal calibradas) y la **hiperactivación paroxística** del pánico nocturno. Su corteza prefrontal dorso-lateral y su red de ejecución central se encontraban completamente inhibidas. No había espacio para la representación ni para el trabajo analítico; el aparato psíquico estaba colapsado.

El síntoma como jeroglífico no metabolizado

Las crisis de pánico no eran meras descargas orgánicas aleatorias; respondían al colapso de su economía narcisística tras una mudanza reciente y la enfermedad crónica de su madre. La exigencia de sostener una vida familiar y laboral hiperdemandante había rebasado su capacidad de ligadura psíquica, volcando el exceso de excitación directamente sobre el soma: taquicardia, ahogo, descarga autonómica.

Oportunidades de Intervención y Herramientas Técnicas

1 La Mesa de Trabajo Transdisciplinaria (Coordinación Fármaco-Analítica)

El analista estableció contacto directo y formal con el médico psiquiatra tratante. Se elaboró un plan de reestructuración farmacológica: descenso progresivo y controlado de las altas dosis de benzodiacepinas, estabilización con un modulador serotoninérgico adecuado e incorporación de un regulador del sueño de perfil no adictivo. El objetivo no era "quitar los remedios", sino **limpiar el ruido neurobiológico diurno** para que la paciente recupere la lucidez cognitiva.

2 La Contención Somato-Vincular y el Ajuste del Encuadre

El analista modificó temporalmente la clásica regla de la asociación libre pasiva, adoptando una posición activa, cálida y de presencia continente. Operó como un **"yo auxiliar" externo** y validó explícitamente el sufrimiento corporal: *"No estás loca ni es una debilidad; tu cuerpo está intentando frenar un tren a 150 kilómetros por hora con las manos."* Esto redujo drásticamente el terror secundario a los síntomas físicos.

3 La Interpretación Focalizada y el Mapeo de los Disparadores Autonómicos

A medida que el reajuste farmacológico ensanchó la ventana de tolerancia, el analista introdujo intervenciones focales. Se trabajó sobre el nexo entre el terror corporal y la exigencia hiperresponsable que Valeria se imponía. Se interpretó que el pánico funcionaba como un **"freno de mano biológico y psíquico"**: el cuerpo decía "basta" mediante el ahogo porque la palabra había sido amordazada por la culpa.

Desenlace clínico

6

Meses de abordaje convergente

Tiempo necesario para lograr la estabilización completa del cuadro clínico.

0

Crisis de pánico activas

Valeria logró estabilizar por completo sus crisis y transitar sus salidas a la calle sin agorafobia.

≈ 0

Benzodiacepinas de rescate

El psiquiatra pudo retirar casi por completo las benzodiacepinas, manteniendo únicamente el soporte de base necesario.

En el espacio analítico, Valeria pudo procesar los duelos pendientes, reconfigurar los límites con su entorno familiar y **abandonar la posición de víctima sufriente de su propio cuerpo.**



La potencia de la Clínica de la Convergencia

La síntesis transformadora

El caso evidenció con nitidez la potencia de la Clínica de la Convergencia: cuando el fármaco deja de ser un instrumento de silenciamiento y se transforma en un **modulador que abre la ventana de tolerancia**, y cuando el psicoanálisis deja de lado su soberbia anti-médica para integrar la materialidad del cuerpo viviente, la cura deja de ser una promesa abstracta y se convierte en un **acontecimiento clínico transformador**.

